

**POE PARA LA GESTIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN**

POE – DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR – V01

Fecha entrada en vigor OCTUBRE 2022

FECHA	REALIZADO: OCTUBRE 2022	REVISADO: OCTUBRE 2022	APROBADO: OCTUBRE 2022
NOMBRE	José Antonio Gascón Jiménez	José Antonio Gascón Jiménez	Francisco Javier Fonseca del Pozo
CARGO	Director de Salud	Director de Salud	Director Gerente
FIRMA	GASCON JIMENEZ JOSE ANTONIO - 30528721Q Firmado digitalmente por GASCON JIMENEZ JOSE ANTONIO - 30528721Q Fecha: 2022.10.20 08:49:20 +02'00'	GASCON JIMENEZ JOSE ANTONIO - 30528721Q Firmado digitalmente por GASCON JIMENEZ JOSE ANTONIO - 30528721Q Fecha: 2022.10.20 08:49:50 +02'00'	
Lugar de archivo Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir			Fecha de revisión 01 / 11 / 2024

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7Allt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/10



1. OBJETO

Este POE tiene como objetivo facilitar a los familiares de un difunto los trámites administrativos necesarios para la firma del certificado de defunción.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de **obligado cumplimiento**, y va dirigido a todos los facultativos del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir.

3. EQUIPAMIENTO NECESARIO

Correo corporativo para difundir el procedimiento entre profesionales.

4. OBLIGACIÓN DE CUMPLIMENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN.

La muerte, el final de la vida, supone una situación de alta intensidad emocional para familiares y amigos, dónde las circunstancias de ésta contribuyen a incrementar aún más el nivel de tensión emotiva.

Facilitar los trámites legales para poder trasladar el cadáver e inhumarlo o incinerarlo debería ser nuestro deber como facultativos, pero la cada vez más acuciante apelación a nuestra responsabilidad civil y penal, y la repercusión mediática de algunos casos de aparente muerte natural envueltas en circunstancias irregulares nos pueden plantear serias dudas éticas y legales a la hora de tener que firmar documentos.

La ley es taxativa al afirmar que el certificado oficial de defunción debe ser cumplimentado y firmado por un médico, que no puede expedirse en caso de muerte no natural, y que sin el certificado oficial de defunción no se pueden iniciar los trámites de traslado e inhumación o incineración del cadáver.

El artículo 274 del Reglamento del Código Civil establece que el facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca el cadáver enviará al Registro parte de defunción en el que, además del nombre, apellidos, carácter y número de colegiación del que lo suscriba, constará que existen señales inequívocas de muerte, su causa y, con la precisión que la inscripción requiere, fecha, hora y lugar del fallecimiento y menciones de identidad del difunto, indicando si es conocido de ciencia propia o acreditada y, en este supuesto, documentos oficiales examinados o menciones de identidad de persona que

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/10



afirme los datos, la cual también firmará el parte. Si hubiere indicios de muerte violenta se comunicará urgente a la autoridad judicial competente.

Por otro lado, el Código de deontología médica en su Capítulo VII, artículo 36, punto 6 establece que aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial sobre el paciente es el que tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción en todos sus apartados, **no es deontológicamente aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando** se ha presenciado la misma, se conoce al paciente o **se tiene a disposición la historia clínica.**

Por todo lo anteriormente expuesto, **cualquier médico** puede certificar como muerte natural una muerte si, en función del conocimiento del paciente, de la documentación disponible y de las circunstancias en que se ha producido, puede identificar o suponer una causa de muerte atribuible.

5.- PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE DISTINTOS SUPUESTOS

MUERTE NATURAL COMO FINAL DE ENFERMEDAD Y MUERTE REPENTINA

Dependiendo de la rapidez con la que tiene lugar el desenlace final, hablamos de **muerte natural** como final de enfermedad cuando esta se produce tras un dilatado periodo de enfermedad, mientras que la **muerte repentina** tiene lugar de forma inesperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de los antecedentes médicos del paciente.

Con independencia de dónde se produzca el fallecimiento, el facultativo que reconoce el fallecimiento lo hará tras la comprobación de ausencia de pulso central y/o latido cardiaco, ausencia de respiración espontánea y ausencia de reflejo corneal o respuesta motora a estímulos durante 5 minutos.

5.1.- EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS (EN EL PROPIO CENTRO)

Cuando el fallecimiento de una persona se produzca en un Servicio de Urgencias, será el médico responsable de la atención el encargado de certificar y emitir el correspondiente certificado de defunción.

En estos casos, tanto si se ha prestado asistencia como si ingresa cadáver, el médico responsable solicitará toda la información disponible a la familia del difunto, tanto de los síntomas previos por lo que decidieron consultar en urgencias, como de diagnósticos y tratamientos del paciente, y si fuese necesario, consultar la HSD del paciente a fin de establecer una causa probable del fallecimiento.

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7A1Lt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/10



En los casos en los que se prevea que el médico que ha asistido y certificado la muerte en el servicio de urgencias no va a poder cumplimentar el certificado de defunción por estar próximo a finalizar su turno de trabajo, el facultativo deberá cumplimentar en la historia de paciente todos los datos necesarios para una posterior cumplimentación del parte de defunción por parte de un facultativo del SUAP.

5.2.- EN RESIDENCIA GERIÁTRICA

En el caso de las residencias geriátricas, se aplicarán los mismos supuestos que en los domicilios particulares, con la salvedad de que, en aquellas residencias que dispongan de personal médico, este sustituirá a su médico de familia del centro de salud para la certificación de la muerte en función de su horario de trabajo

5.3.- EN DOMICILIO PARTICULAR

5.3.1.- EN HORARIO DE MAÑANA (De 8:00 a 15:00 horas)

A: Para certificación de muerte:

- **Con apertura de Centro de Salud:** Todo aviso para certificación de muerte en domicilio será notificado a su médico de familia como **prioridad 3**, siendo este el encargado de visitar el domicilio, certificar la muerte y emitir el correspondiente certificado de defunción, si procede.

Si bien es cierto que una prioridad 3 para Atención Primaria no obliga a abandonar la consulta de forma inmediata para acudir al domicilio, no es menos cierto que debemos colaborar en agilizar los trámites necesarios para la certificación del fallecimiento acudiendo lo antes posible en el primer hueco disponible.

En el caso de que su médico de familia estuviera ausente por estar en otro turno, disfrute de permiso reglamentario o cualquier otra situación, desde la UAC asignarán el aviso a otro facultativo siguiendo las normas internas de repartos establecidas. En este caso, el nuevo médico asignado hará la valoración presencial y, recabando la información necesaria en el domicilio así como en su historia clínica, procederá a la emisión del correspondiente certificado de defunción.

En los casos en los que se prevea que el médico que ha asistido y certificado la muerte en el domicilio no va a poder cumplimentar el certificado de defunción por no estar disponible en el domicilio y estar próximo a finalizar su turno de trabajo, el facultativo deberá cumplimentar en la historia de paciente todos los datos

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/10



necesarios para una posterior cumplimentación del parte de defunción por parte de otro facultativo del centro de salud o SUAP (**solo en los casos en los que haya solo turno de mañana en el centro de salud**).

- **Fines de semana y festivos:** Todo aviso para certificación de muerte en domicilio será notificado al equipo móvil como **prioridad 3**, siendo este el encargado de visitar el domicilio, certificar la muerte y emitir el correspondiente certificado de defunción, si procede.

B: Para asistencia urgente con resultado de muerte:

- En todo aviso para la atención urgente de un paciente por el equipo móvil (DCCU o 061) cuyo resultado es el fallecimiento, tanto si ha recibido atención por parte del equipo como si no, será el facultativo que reconoce el cadáver y certifica el fallecimiento el encargado de la posterior emisión de correspondiente certificado de defunción.

Para ello, deberá solicitar toda la información necesaria sobre padecimientos previos y tratamientos del paciente a la familia, informes de ingresos previos, si los hubiera, o cualquier otra documentación que pudiera ayudar al médico a establecer una causa probable de defunción. En caso necesario, el facultativo podrá completar la información obtenida consultando la HSD del usuario.

5.3.2.- EN HORARIO DE TARDE-NOCHE (De 15:00 a 00:00 horas)

A: Para certificación de muerte:

- Todo aviso para certificación de muerte en domicilio será traspasado al equipo móvil del SUAP como **prioridad 3**, siendo éste el encargado de visitar el domicilio, certificar la muerte y emitir el correspondiente certificado de defunción, si procede.

B: Para asistencia urgente con resultado de muerte:

- En todo aviso para la atención urgente de un paciente por el equipo móvil (DCCU o 061) cuyo resultado es el fallecimiento, tanto si ha recibido atención por parte del equipo como si no, será el facultativo que reconoce el cadáver y certifica el fallecimiento el encargado de la posterior emisión de correspondiente certificado de defunción.

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/10



Para ello, deberá solicitar toda la información necesaria sobre padecimientos previos y tratamientos del paciente a la familia, informes de ingresos previos, si los hubiera, o cualquier otra documentación que pudiera ayudar al médico a establecer una causa probable de defunción. En caso necesario, el facultativo podrá completar la información obtenida consultando la HSD del usuario.

5.3.3.- EN HORARIO DE NOCHE (De 00:00 a 8:00 horas)

A: Para certificación de muerte:

- **Con apertura de Centro de Salud al día siguiente:** Todo aviso para certificación de muerte en domicilio será notificado al equipo móvil del SUAP como **prioridad 3**. Una vez certificado el fallecimiento, el facultativo responsable cumplimentará los datos del **ANEXO 1**, que servirá posteriormente a su médico de familia para la emisión del certificado de defunción.

En estos casos, será su médico de familia quién, con el Anexo 1 cumplimentado por el equipo móvil del SUAP que certificó el fallecimiento, junto con los datos de la historia, el encargado de emitir el certificado de defunción correspondiente al día siguiente.

Durante la mañana, tanto si es la funeraria como los familiares del paciente los que contactan con la UAC, deberán disponer de la documentación necesaria para la certificación (Anexo 1 y Certificado Médico Oficial de Defunción) por lo que tras su comprobación, desde la UAC se notificará al médico responsable para que proceda a la atención y emisión del certificado de defunción.

En el caso de que su médico de familia estuviera ausente por estar en otro turno, disfrute de permiso reglamentario o cualquier otra situación, desde la UAC asignarán el caso a otro facultativo siguiendo las normas internas de repartos establecidas. En este caso, el nuevo médico asignado valorará la historia del paciente y el Anexo 1 y procederá a la emisión del correspondiente certificado de defunción.

- **Sin apertura de centros de salud al día siguiente:** Todo aviso para certificación de muerte en domicilio será notificado al equipo móvil del SUAP como **prioridad 3**, siendo este el encargado de visitar el domicilio, certificar la muerte y emitir el correspondiente certificado de defunción, si procede.

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/10



En los casos en los que se prevea que el médico que ha asistido y certificado la muerte en el domicilio no va a poder cumplimentar el certificado de defunción por estar próximo a finalizar su turno de trabajo, el facultativo deberá cumplimentar en la historia de paciente todos los datos necesarios para una posterior cumplimentación del parte de defunción por parte de otro facultativo del SUAP.

B: Para asistencia urgente con resultado de muerte:

- En todo aviso para la atención urgente de un paciente por el equipo móvil (DCCU o 061) cuyo resultado es el fallecimiento, tanto si ha recibido atención por parte del equipo móvil como si no, será el facultativo que reconoce el cadáver y certifica el fallecimiento el encargado de la posterior emisión de correspondiente certificado de defunción.

Para ello, deberá solicitar toda la información necesaria sobre padecimientos previos y tratamientos del paciente a la familia, informes de ingresos previos si los hubiera, o cualquier otra documentación que pudiera ayudar al médico a establecer una causa probable de defunción. En caso necesario, el facultativo podrá completar la información obtenida consultando la HSD del usuario.

En los casos en los que se prevea que el médico que ha asistido y certificado la muerte en el domicilio no va a poder cumplimentar el certificado de defunción por estar próximo a finalizar su turno de trabajo, el facultativo deberá cumplimentar en la historia de paciente todos los datos necesarios para una posterior cumplimentación del parte de defunción por parte de un facultativo del mismo equipo que lo atendió (DCCU o 061)

5.4.- EN VÍA PÚBLICA

Cuando una persona fallece en un lugar público, el fallecimiento debe ser comunicado al juzgado y asistir el médico forense, aunque posteriormente por las características del caso, proceda la emisión del certificado médico correspondiente.

MUERTE SÚBITA

Se entiende como tal la muerte inesperada, sin signos de violencia o sospecha de criminalidad, en una persona aparentemente sana, y que en consecuencia, no es explicable a la luz de los antecedentes.

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/10



Se trata de sujetos en los que el médico no tiene constancia, directamente o por manifestación de terceros, de antecedentes patológicos relevantes o de síntomas previos a la defunción que lo justifiquen.

El médico que reconoce el cadáver emitirá (y guardará) el correspondiente Parte al Juzgado de Guardia disponible en Diraya, activando el protocolo judicial.

MUERTE VIOLENTA

Se trata de muertes desencadenadas por algún mecanismo exógeno atribuible a una etiología accidental, suicida y homicida.

Son consideradas muertes violentas:

- Homicidio o sospecha de homicidio.
- Muerte súbita e inesperada, incluyendo el síndrome de muerte súbita del lactante.
- Cualquier violación de los derechos humanos como sospecha de tortura o cualquier forma de maltrato.
- Suicidio o sospecha de suicidio
- Sospecha de mala praxis médica.
- Accidentes de circulación, laborales y domésticos.
- Intervalo postmortal muy prolongado (estado de putrefacción)

En toda muerte violenta, aun siendo evidente la causa y mecanismo de la misma, el facultativo que asiste al difunto o lo reconoce inmediatamente después de la muerte, deberá emitir (y guardar) el correspondiente Parte al Juzgado de Guardia disponible en Diraya y activar el protocolo judicial.

MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD

Se considera muerte sospechosa de criminalidad toda muerte en la que, aún no siendo evidentes los signos de violencia, podemos sospechar una etiología accidental, suicida, homicida o una acción intercurrente de la que pueda derivar responsabilidad de una tercera persona.

Toda muerte sospechosa de criminalidad debe comunicarse al Juzgado de Guardia y activar el protocolo judicial, utilizando el modelo de Parte al Juzgado de Guardia disponible en Diraya, que será guardado en la historia del paciente.

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/10



6. LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO 1: Documento de constatación de muerte a efectos de emisión de certificado de defunción por su médico de familia

7. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El procedimiento una vez aprobado se distribuirá a todos los profesionales del Distrito Córdoba-Guadalquivir.

8. BIBLIOGRAFIA

- Acuerdo de colaboración de la comisión de seguimiento del protocolo general de colaboración entre las anteriores consejerías de gobernación y justicia y de salud, para unificar las actuaciones del personal sanitario y médico forense de la comunidad autónoma de Andalucía en caso de defunción.

Código:	6hwMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/10



ANEXO 1

DOCUMENTO DE CONSTATACIÓN DE MUERTE NATURAL A EFECTOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN POR SU MÉDICO DE FAMILIA

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE (Acreditada mediante DNI)

NOMBRE

DNI FECHA NACIMIENTO

DATOS PARA LA CERTIFICACIÓN

D. _____, licenciado en Medicina y Cirugía, colegiado en _____, con el número _____, informa que siendo las _____ horas del día ____ de _____ de 20____, he constatado la muerte del paciente arriba indicado y cuya identidad se me ha acreditado por parte de la familia mediante DNI en el domicilio situado en la calle _____ nº _____ en la población de _____

Tras la inspección del fallecido no se aprecian signos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, aportando la familia información referente a sus patologías previas, cuales son:

1		3	
2		4	

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en la población de _____ a ____ de _____ de 20____

Firma del facultativo

Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir
C/Isla de Lanzarote, 3
14011 – Córdoba

Código:	6hWMS693PFIRMANh8Vc5a/7ALLt+k8	Fecha	20/10/2022
Firmado Por	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO	Página	10/10
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		

